Entrevista con la Dra. Sara Ordóñez

Proyecto NutriAgenda · Equipo T6 – Los Guayabyte · Ingeniería de Software I

Fecha: _____ · Duración: 45–50 minutos · Asistentes: _____

Apertura

> ***Pablo:*** *«Doctora, muchas gracias por su tiempo. Hoy queremos hacer tres cosas: que nos cuente algunos casos reales para entender bien su trabajo, mostrarle lo que pensamos para el sistema para que lo corrija, y conocer los detalles que nos faltan. Serán unos 45 minutos. ¿Nos permite grabar la reunión? Es solo para el proyecto y no se publica.»*

☐ **1.** Desde la última vez que hablamos, ¿hubo algún cambio en el consultorio que debamos saber?

Parte A. Casos reales

> ***Pablo:*** *«Le vamos a pedir que nos cuente tres situaciones como si estuvieran pasando hoy.»*

Caso 1. Llega un paciente derivado nuevo

☐ **2.** Imagine que hoy un médico le deriva un paciente nuevo del programa. ¿Nos cuenta todo lo que pasa, desde que usted se entera hasta que ese paciente tiene su segunda cita del mes?

Repreguntar solo lo que no haya mencionado:

- ☐ ¿Cómo se entera del paciente y qué datos le pasa el médico?
- ☐ ¿Quién registra al paciente? ¿Qué datos son indispensables y cuáles opcionales?
- ☐ ¿Qué preguntas no pueden faltar en la historia clínica? ¿Cambian si viene por cirugía, por medicación o es propio?
- ☐ ¿Cuándo envía cada uno de los tres mensajes previos? ¿Desde qué correo y qué número de WhatsApp?
- ☐ ¿El paciente elige el horario o se lo asignan? ¿La cita queda firme o usted la aprueba?
- ☐ ¿Qué días y horarios atiende? ¿Cuánto dura la primera consulta, un control y una con bioimpedancia?
- ☐ Si la consulta es en línea, ¿qué plataforma usa y quién envía el enlace?
- ☐ Si el paciente no llena la historia antes de la cita, ¿qué debería pasar? ¿Cuántas veces le recordamos?
- ☐ ¿Cuántos recordatorios de la cita quiere y con cuánta anticipación?
- ☐ ¿Cómo se programa la segunda cita del mes? ¿Quién elige la fecha y qué pasa si el paciente no puede ese día?
- ☐ En la consulta toma datos como peso y bioimpedancia. ¿Le serviría guardarlos y ver el avance del paciente?
- ☐ ¿Le informa algo al médico que lo derivó? ¿Qué y cada cuánto?

Caso 2. Un paciente cancela y otro no llega

☐ **3.** Ahora imagine que un paciente le escribe una hora antes para cancelar, y otro simplemente no llega. ¿Qué pasa hoy en cada caso y qué le gustaría que pase?

Repreguntar solo lo que no haya mencionado:

- ☐ ¿Con cuántas horas de anticipación debe avisar para que no cuente como falta?
- ☐ La cancelación permitida, ¿es una por mes o una por paquete? ¿Reprogramar cuenta como cancelación?
- ☐ ¿Cuántas veces puede un paciente reprogramar la misma cita?
- ☐ ¿Qué hacemos con el horario que queda libre? ¿Se lo ofrecemos a otro paciente?
- ☐ ¿Quiere que la app le avise al momento? ¿De qué otras cosas quiere avisos?
- ☐ ¿Y si es usted quien debe cancelar por un viaje, un feriado o un imprevisto? ¿Cómo bloquea esos días?
- ☐ ¿Su asistente también puede agendar, mover o cancelar citas por el paciente?

Caso 3. Fin de mes

☐ **4.** Imagine que es fin de mes y quiere saber cómo le fue y cómo van sus paquetes. ¿Qué revisa hoy y qué le gustaría ver?

Repreguntar solo lo que no haya mencionado:

- ☐ ¿Qué pasa con las consultas que el paciente no usó en el mes? ¿Cómo se renueva un paquete?
- ☐ ¿Qué datos anota hoy en su Excel de paquetes y pagos? ¿Quién paga: el paciente o el programa? ¿Cómo le pagan?
- ☐ ¿Qué números quiere ver en el reporte? ¿Lo necesita en Excel o en PDF? ¿Se lo entrega a alguien?
- ☐ En un mes normal, ¿cuántas citas tiene y cuántas se cancelan el mismo día?
- ☐ ¿Cuántas horas a la semana se van en agendar citas y enviar mensajes?

Parte B. Reglas y casos especiales

☐ **5.** Hay reglas que en su consultorio se cumplen siempre, por ejemplo que los derivados tienen dos consultas al mes. ¿Nos puede decir, una por una, qué otras reglas se cumplen siempre?

☐ **6.** Hay momentos en que el sistema debería hacer algo solo: cuando alguien reserva, cancela, paga, completa su historia o se le está por acabar el paquete. ¿Qué le gustaría que pase en cada uno de esos momentos?

☐ **7.** Algunos datos se podrían calcular solos, como las consultas que le quedan a un paciente o la fecha de su segunda cita. ¿Cómo los calcula usted hoy?

☐ **8.** ¿Qué casos raros le han pasado? Por ejemplo, dos pacientes en el mismo horario, un paciente que cambia de médico o una cita que pasa de un mes a otro. ¿Qué hizo en ese momento?

Parte C. Revisar lo que pensamos para el sistema

> ***Pablo:*** *«Ahora le vamos a leer lo que entendimos y dimos por hecho. Díganos si es así o cómo lo cambiaría.»*

☐ **9.** Los pacientes no instalan nada ni crean usuario: todo lo hacen desde enlaces que les llegan.

☐ **10.** El paciente agenda, confirma, cancela o reprograma su cita desde el enlace, en los horarios que usted define.

☐ **11.** El paciente llena su historia clínica desde el enlace antes de la consulta, y usted ve si está completa o pendiente.

☐ **12.** Los pacientes derivados tienen dos consultas al mes, y la segunda se agenda sola.

☐ **13.** Se permite una sola cancelación; desde la segunda, la consulta se da por realizada.

☐ **14.** Antes de la consulta se envían tres mensajes: la historia clínica, la bienvenida con las políticas del programa y las indicaciones para la bioimpedancia. El recordatorio llega 24 horas antes.

☐ **15.** Los correos salen solos; el WhatsApp queda escrito y usted o su asistente lo envían con un toque.

☐ **16.** Cada cita aparece en su Outlook con el nombre del paciente, la modalidad y si la historia está completa.

☐ **17.** El sistema controla las consultas usadas y pendientes de cada paquete, los pagos y las cancelaciones, y le da un reporte mensual de consultas por paciente y modalidad.

☐ **18.** Su asistente carga al sistema los pacientes que hoy tiene en Word y Excel.

☐ **19.** Quedan para después: mensajes de cumpleaños y motivacionales, cobro en línea, factura electrónica, videollamadas dentro del sistema y el cuestionario de filtro.

☐ **20.** De todo esto, ¿qué no puede faltar desde el inicio, qué sería bueno tener y qué puede esperar?

Parte D. Cómo debe funcionar el sistema y qué es más importante

Pablo: *«Estas son las condiciones que pensamos para que el sistema funcione bien, y la importancia que le dimos a cada una. Queremos que las revise y nos diga si está de acuerdo con el valor y con la importancia.»*

#	Condición del sistema	Importancia que le dimos	Su opinión
R3	**Seguridad.** Cada enlace es único, solo abre la cita de ese paciente y deja de funcionar 48 horas después de la cita. Su app pide una contraseña de al menos 8 caracteres y se cierra tras 15 minutos sin uso.	Imprescindible	
R4	**Facilidad.** Un paciente nuevo llena su historia clínica en 10 minutos o menos desde el celular, sin crear cuenta ni instalar nada. Se prueba con 5 pacientes y al menos 4 lo logran sin ayuda.	Imprescindible	
R5	**Respaldo.** Se guarda una copia de la información cada 24 horas durante 30 días. Si algo falla, se recupera en menos de 4 horas y se pierde como máximo un día. Los datos van protegidos según la Ley de Protección de Datos.	Imprescindible	
R6	**Outlook.** Cada cita confirmada, movida o cancelada aparece en su Outlook en 1 minuto o menos, con el nombre del paciente, la modalidad y si la historia está completa.	Imprescindible	
R2	**Rapidez.** Cuando un paciente confirma, usted lo ve en su app en 30 segundos o menos, en 95 de cada 100 casos.	Importante	
R7	**Mensajes.** Los tres mensajes previos fallan como máximo 1 de cada 200. Si uno falla, se reintenta hasta 3 veces en 30 minutos y, si sigue fallando, se le avisa en la app.	Importante	
R1	**Disponibilidad.** El sistema funciona el 99 % del mes. Los mantenimientos son entre las 10 pm y las 6 am y se le avisan con 48 horas de anticipación.	Deseable	
R8	**Capacidad.** El sistema soporta 500 pacientes registrados y 20 llenando formularios al mismo tiempo.	Para más adelante	

Imprescindible: va sí o sí desde el inicio. Importante: se intenta incluir desde el inicio. Deseable: se incluye si alcanza el tiempo. Para más adelante: no entra en la primera versión.

☐ **21.** ¿Está de acuerdo con la importancia que le dimos a cada condición? ¿Cuál movería y por qué?

☐ **22.** ¿Algún valor le parece muy exigente o muy poco, como los tiempos, los 15 minutos o las 48 horas? ¿Cómo lo dejaría?

☐ **23.** Para la seguridad, ¿basta con el enlace o le pedimos al paciente un dato, como su cédula, para confirmar que es él?

☐ **24.** ¿Usted o sus pacientes usan el sistema entre las 10 pm y las 6 am? ¿Le estorbaría que la app se cierre tras 15 minutos sin uso durante la consulta?

☐ **25.** Si un mensaje no se envía, ¿a quién le avisamos: a usted o a su asistente?

☐ **26.** ¿Cuántos pacientes atiende al mes y cuántos espera tener en un año?

☐ **27.** ¿Cómo le gustaría comprobar que el sistema cumple estas condiciones? Por ejemplo, probarlo con algunos pacientes o revisar juntas que las citas lleguen a su Outlook.

☐ **28.** Los mensajes a los pacientes podrían llevar solo la fecha, la hora y el enlace, sin datos de salud. ¿Le parece bien así o necesita que incluyan algo más?

☐ **29.** Pensamos que su asistente pueda aprender a usar el sistema en una sesión de una hora. ¿Le parece suficiente o necesitaría más tiempo?

Parte E. Cómo quiere que se vea

> ***Pablo:*** *«Estas son las pantallas que pensamos para el sistema. ¿Nos dice si falta o sobra alguna?»*

- **Paciente (enlace):** reservar la cita, confirmarla, cancelarla o reprogramarla, llenar la historia clínica, aviso de enlace vencido y mensaje de éxito.
- **Usted (app):** inicio de sesión, agenda, detalle de la cita, ficha del paciente y avisos.
- **Asistente (computadora):** inicio de sesión, pacientes, historias llenadas, horarios, mensajes, paquetes y pagos, y reportes.

☐ **30.** ¿Esta lista de pantallas está completa? ¿Falta o sobra alguna?

☐ **31.** Cuando abra la app en la mañana, ¿qué necesita ver primero?

☐ **32.** Al ver una cita, ¿qué le gustaría hacer con un solo toque? Por ejemplo, ver la historia, escribirle por WhatsApp o reprogramarla.

☐ **33.** Cuando el paciente abre el enlace, ¿qué debería ver primero? ¿Tiene logo o colores del consultorio? ¿Hay alguna aplicación que le guste cómo se ve?

☐ **34.** Cuando algo sale mal, como un enlace vencido o un horario ocupado, ¿qué le gustaría que diga el sistema?

Parte F. Quiénes lo usan y sus datos

☐ **35.** Usted usaría el sistema desde su iPhone y su asistente desde la computadora, ¿es así? ¿Qué tan cómodas se sienten con la tecnología? ¿Sus pacientes mayores podrían usarlo solos?

☐ **36.** ¿Qué puede hacer cada persona en el sistema? Completemos juntas esta tabla con «Sí», «No» o «Solo ver».

Función	Doctora	Asistente	Paciente
Ver la ficha completa			No
Editar la ficha			Solo sus datos
Ver la historia clínica y notas			No
Agendar, mover o cancelar citas			Solo las suyas
Registrar pagos y paquetes			No
Ver reportes			No
Editar los textos de los mensajes			No
Configurar horarios			No

☐ **37.** Por la Ley de Protección de Datos, el paciente debe aceptar el uso de su información. ¿Hoy les pide algún consentimiento? ¿Cuánto tiempo guarda las historias clínicas?

☐ **38.** El sistema tiene un pequeño costo mensual de funcionamiento. ¿Qué presupuesto le parece razonable? Si lo sigue usando después del curso, ¿quién le daría soporte? ¿El Omni Hospital tiene reglas sobre sistemas o datos de pacientes?

Cierre

☐ **39.** ¿Qué es lo peor que podría pasar con el sistema? Por ejemplo, un mensaje a la persona equivocada o una cita duplicada. ¿Qué haría usted en ese caso?

☐ **40.** ¿Qué le haría decir «este sistema no me sirve»?

Pablo: *«Con todo lo que nos contó vamos a preparar el documento de requerimientos y se lo enviaremos para que lo revise y firme su conformidad. En la próxima reunión le mostraremos cómo se verá el sistema. ¿Qué días le quedan mejor? Y una última consulta: ¿nos permite usar capturas del sistema con datos ficticios en nuestro trabajo? Muchas gracias por su tiempo, doctora.»*

Preguntas adicionales

Para usar si sobra tiempo, si la doctora se extiende en un tema o en la próxima reunión.

Pacientes y ficha

- ☐ Puede haber pacientes con el mismo nombre. ¿Cómo los diferencia? ¿Atiende extranjeros sin cédula o menores de edad?
- ☐ Un paciente puede volver después de meses. ¿Qué debe pasar con su información anterior?
- ☐ Si un paciente deja de venir, ¿se archiva, se borra o puede reactivarse? ¿Desde cuándo lo considera inactivo?
- ☐ ¿Qué debe pasar con sus citas y mensajes pendientes si un paciente se da de baja?
- ☐ Para encontrar rápido a un paciente, ¿por qué datos lo buscaría: nombre, cédula, programa o médico?
- ☐ Al abrir la ficha de un paciente, ¿qué quiere ver primero: próxima cita, motivo, paquete o últimas medidas?
- ☐ ¿Le gustaría ponerle notas o etiquetas libres a cada paciente?
- ☐ ¿Qué formato deben tener datos como la cédula, el teléfono o el correo? ¿Qué mensaje de error le parece claro?

Historia clínica y formularios

- ☐ ¿El paciente puede guardar el formulario a medias y seguir después?
- ☐ ¿Cuándo se considera completa la historia: con todas las respuestas o solo con las obligatorias?
- ☐ ¿El paciente puede subir exámenes o fotos? ¿De qué tipo?
- ☐ ¿Se puede corregir la historia después de enviarla? ¿Quién puede hacerlo?
- ☐ ¿La historia se actualiza en cada consulta o hay un formulario de control distinto?
- ☐ ¿Le gustaría poder cambiar las preguntas del formulario usted misma?
- ☐ Si el paciente marca una alergia o enfermedad, ¿quiere que el sistema se la resalte?
- ☐ Al ver una cita, ¿quiere ver solo si la historia está completa o un resumen de las respuestas?
- ☐ ¿Los programas o los médicos que derivan exigen algún formato de historia?

Citas y agenda

- ☐ ¿Deja tiempo libre entre una cita y otra? ¿Cuánto?
- ☐ ¿Con cuánta anticipación mínima y máxima se puede agendar? ¿Se puede agendar para el mismo día?
- ☐ ¿Un paciente puede tener más de una cita futura a la vez?
- ☐ Si un paciente llega tarde, ¿hay tolerancia? ¿Se registra como inasistencia?
- ☐ ¿Atiende pacientes sin cita o en sobrecupo? ¿Cómo los registra?
- ☐ ¿Algunos pacientes necesitan citas fijas, por ejemplo cada 15 días?
- ☐ ¿Cómo quiere ver su agenda en el celular: por día, por semana o en lista?
- ☐ Si usted mueve una cita directamente en Outlook, ¿debería cambiar también en el sistema?
- ☐ ¿Atiende en línea a pacientes de otros países, con otra hora?

Paquetes y pagos

- ☐ ¿Hay distintos tipos de paquete? ¿Cuánto cuestan y cuánto duran?
- ☐ ¿Se puede congelar un paquete por viaje o enfermedad? ¿Quién decide las excepciones?
- ☐ ¿Los pacientes propios pagan por consulta? ¿Quiere registrar esos pagos también?
- ☐ ¿El pago es total por adelantado o por partes? ¿Hay deudas que el sistema deba controlar?
- ☐ ¿Necesita entregar un recibo o comprobante, aunque no sea factura electrónica?
- ☐ Cuando se acaban las sesiones de un paquete, ¿qué debe pasar: aviso, oferta de renovación o bloqueo para agendar?
- ☐ ¿El paciente derivado debería ver cuántas consultas le quedan en su paquete?
- ☐ ¿Se le informa al médico que deriva cuando un paciente cancela o abandona el programa?
- ☐ ¿Hay descuentos, promociones o devoluciones de dinero?

Mensajes y comunicación

- ☐ ¿Qué datos debe llevar cada mensaje: nombre, fecha, hora, dirección, enlaces para confirmar o cancelar?
- ☐ ¿Qué tono prefiere en los mensajes: formal o cercano, de «usted» o de «tú», con emojis o con firma?
- ☐ Si el paciente no tiene correo o el correo rebota, ¿qué hacemos?
- ☐ ¿Los pacientes responden a los correos? ¿A qué correo o teléfono deben llegar esas respuestas?
- ☐ ¿Hay horarios en que no se deben enviar mensajes, como la noche o los fines de semana?
- ☐ ¿Qué mensaje se envía cuando un paciente cancela o reprograma? ¿Y uno de agradecimiento después de la consulta?
- ☐ ¿Le serviría ver el historial de mensajes enviados a cada paciente?
- ☐ ¿Se puede incluir información de salud en los mensajes o es mejor evitarla?
- ☐ De los mensajes de cumpleaños, motivacionales y para pacientes inactivos, ¿cuál le daría más valor a futuro?

Reportes

- ☐ ¿Quiere que el reporte llegue solo cada mes o generarlo cuando lo necesite?
- ☐ ¿Por qué filtros lo revisaría: fechas, tipo de paciente, médico que deriva o modalidad?
- ☐ ¿Le servirían gráficos, como las cancelaciones o la ocupación de su agenda?
- ☐ ¿Necesita un reporte separado para cada médico que le deriva pacientes?
- ☐ ¿Le gustaría comparar con meses anteriores?

Seguridad y datos

- ☐ ¿Cómo prefiere entrar a la app: con clave, huella o Face ID?
- ☐ Si pierde o le roban el celular, ¿qué debería pasar con su sesión?
- ☐ ¿Necesita saber quién vio o cambió la ficha de un paciente y cuándo?
- ☐ Si un paciente pide borrar sus datos, ¿qué hacemos con su historia?
- ☐ ¿Le importa si la información se guarda en servidores fuera del país?
- ☐ Si cambia de asistente, ¿cómo se le quita el acceso a la anterior?
- ☐ ¿Qué datos de salud no deberían verse nunca en una pantalla compartida, un correo o un WhatsApp?

Usuarios, entorno y soporte

- ☐ ¿Cómo es el internet en el consultorio? ¿Se cae a veces? ¿Necesita ver algo sin conexión?
- ☐ ¿Su asistente usa siempre la misma computadora? ¿La comparte con otras personas?
- ☐ ¿Necesita letra grande u otras ayudas para leer en pantalla?
- ☐ ¿Cuánto tiempo podrían dedicar usted y su asistente a aprender a usar el sistema? ¿Le serviría un manual corto?
- ☐ Si algo falla, ¿a quién llamaría y en cuánto tiempo espera una respuesta?
- ☐ ¿Podría crecer el consultorio, por ejemplo con otro profesional que use el sistema?
- ☐ ¿Ha usado antes algún programa de agenda o de historias clínicas? ¿Qué no le gustó?

Prototipo y aprobación

- ☐ ¿Cómo prefiere revisar el prototipo: en persona, por videollamada o con un enlace en su celular?
- ☐ ¿Qué prefiere ver primero: bocetos simples o pantallas con datos de ejemplo que se puedan tocar?
- ☐ ¿Qué tareas debería poder hacer sola en el prototipo para darlo por bueno? Por ejemplo, ver la agenda de mañana.
- ☐ ¿Cómo le gustaría moverse entre pantallas: menú abajo, botón atrás o atajos?
- ☐ ¿Quién aprueba el prototipo y cómo: con firma o con un mensaje?
- ☐ ¿Prefiere que en lo público usemos un nombre genérico en lugar del nombre de su consultorio?
- ☐ ¿Hay algo que el sistema nunca debería hacer?

Metas, fechas y futuro

- ☐ Proponemos reducir en 30 % las cancelaciones del mismo día y en 50 % el tiempo en agendar y enviar mensajes. ¿Le parecen metas realistas? ¿Cuál sería su meta?
- ☐ Hoy, ¿qué parte de sus pacientes llena la historia antes de la primera cita?
- ☐ ¿Cuánto le cuesta una consulta perdida, en tiempo y movilización?
- ☐ ¿Hay alguna fecha en la que necesite que algo ya funcione?
- ☐ ¿Hay fechas en que usted o su asistente no estarán disponibles en los próximos meses?
- ☐ ¿Piensa usar el sistema con pacientes reales después del curso? ¿Desde cuándo?

Si la asistente está presente en la reunión

- ☐ ¿Cómo agenda hoy una cita, paso a paso? ¿Qué errores o confusiones pasan?
- ☐ ¿Qué mensajes envía y cuánto tiempo le toma al día?
- ☐ ¿Qué datos de pacientes busca o escribe con más frecuencia? ¿Dónde los encuentra?
- ☐ ¿Cómo controla los paquetes y los pagos? ¿Dónde se equivoca más?
- ☐ ¿Qué es lo que más le complica el trabajo y qué le gustaría que el sistema haga por ella?
- ☐ ¿Qué tan cómoda se siente usando tablas y páginas web en la computadora?